

Université de Constantine 3 - Faculté de médecine

Centre Hospitalo-universitaire de Constantine Dr Benbadis

Service de Médecine Interne

Sémiologie de l'appareil génital **masculin**

Cours de sémiologie destiné aux étudiants en 3ème année médecine

Enseignante : Dr Kermiche.M

Médecin assistante en médecine interne

Année 2021-2022-2023

Plan du cours :

- Rappel anatomique
- Rappel physiologique
- Etude sémiologique
 - 1-Interrogatoire
 - 2-Examen clinique
- Anomalies à l'examen de l'appareil génital de l'homme

Sémiologie de l'appareil génital masculin

Rappel anatomique

- l'appareil génital de l'homme est composé :

- Des testicules
- Des voies excrétrices
 - Voies excrétrices intra-testiculaires : tubes droits, rete testis
 - Canaux efférents
 - Epididyme
 - Canal déférent
 - Urètre
- Des glandes annexes
 - Vésicules séminales
 - Prostate

Les spermatozoïdes élaborés au sein des tubes séminifères qui se réunissent au niveau de la tête de l'épididyme. L'épididyme est au-dessus de la bourse, prolongé par le canal déférent qui traverse la bourse et se termine par l'ampoule déférentielle qui va former avec les vésicules séminales le canal éjaculateur s'abouchant au niveau de la prostate dans l'urètre prostatique.

Vascularisation :

Le testicule & l'épididyme sont vascularisés par 3 types d'artères :

- artère testiculaire (née de l'aorte), artère déférentielle et artère funiculaire.

C'est une vascularisation terminale principalement par l'artère testiculaire (pas de réseau de suppléance)

Rappel physiologique

Puberté :

Premier signe vers l'âge de 13ans :

Développement de la verge, scrotum et de la pilosité pubienne.

Spermatogenèse : complète vers l'âge de 16 à 17ans.

Pilosité des aisselles, la barbe, et du corps n'atteint leur développement final qu'à l'âge de 18ans.

Etude sémiologique

Repose sur l'interrogatoire et essentiellement sur l'examen clinique

1-Interrogatoire:

- Age de la puberté
- Notion de dysurie
- Écoulement urétéral
- Ulcération des organes génitaux externes
- Baisse du libido

-Notion de rapports sexuels non protégés

2-Examen clinique

Inspection :

Pilosité pubienne, de forme losangique

Inspection associée à la palpation de la verge :

Recherche en premier l'existence d'une circoncision (méat visible) :

Priapisme : Erection irréductible, permanente et douloureuse en rapport avec une thrombose du corps caverneux

LE SCROTUM

-Peau scrotale plissée, souple, indolore

-On cherche le réflexe crémasterien : avec une stimulation cutanée, contraction muscle crémaster ; ascension du testicule, cela veut dire que les innervations et la vascularisation sont bonnes

LE TESTICULE : Consistance ferme, régulière, élastique, indolore, forme ovoïde

C'est un examen bilatéral & comparatif : palper bi manuel

-Volume d'un testicule normal : 15-20 ml (hypotrophie : 6-13ml et atrophie : < 6 ml)

-Corrélation entre le volume testiculaire et l'état de la spermatogénèse

-Atrophie, hypotrophie : hypospermatogénèse (par spermogramme)

-Volume normal : spermatogénèse normale

L'EPIDIDYME:

-Coiffe le testicule

-5 x 1cm

-Glande qui s'étend sur toute la partie haute du testicule

-Lisse, indolore

-On palpe la tête, corps, queue, anse

-On doit palper le sillon épидидymo-testiculaire à l'état normal (simple à réaliser) = manœuvre de Chevassu

LE CANAL DEFERENT

-Il est normalement palpable dans sa position intra scrotale (on peut palper les 2)

-Consistance : corde rigide indolore

-Recherche d'un écoulement urétral ou d'une inflammation du méat lorsqu'il est visible

-Recherche des lésions tumorales, des ulcérations douloureuses ou non (chancre syphilitique)

En cas de non circoncision on doit rétracter le prépuce pour explorer le méat :

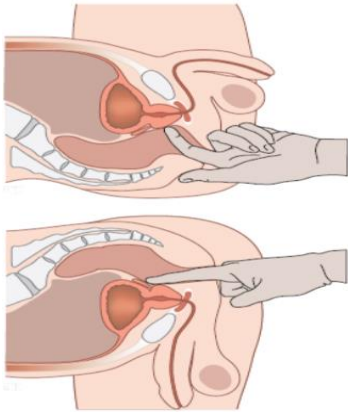
Phimosis : le prépuce ne peut être rétracté derrière le gland

Paraphimosis : le prépuce est déjà rétracté et resserré de sorte qu'on ne peut le ramener sur le gland

- Inspection associée à la palpation du scrotum :

- On palpe sous la peau scrotale la vaginale : séreuse qui enveloppe les testicules que l'on peut pincer
- Deux testicules : sensibles à la pression
- Epididyme couché sur le bord postéro-supérieur du testicule
- Segment inférieur du canal deferent faisant suite à la queue de l'épididyme qui donne une sensation particulière de corde fouet

◦ **Examen de la prostate :**



Toucher rectal :

Se fait soit en position genu-pectoral ou en décubitus dorsal, il permet la palpation de la prostate qui se situe contre la face antérieure du rectum

Etat normal :

-Glande de petite taille, symétrique, mobile, élastique, sous forme de carte à jouer ou en châtaigne, avec un sillon médian vertical

Etat pathologique :

-Toute protrusion indique une hypertrophie

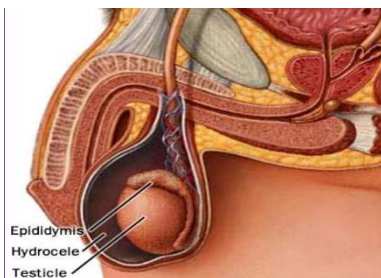
Les anomalies à l'examen de l'appareil génital masculin :

1. **Une ectopie testiculaire ou cryptorchidie :**

Anomalie de migration du testicule qui peut être uni ou bilatéral : absence d'un ou de deux testicules dans les bourses.

A l'examen, la bourse est vide, on recherche le ou les testicules dans la région inguinale, lorsqu'il est retrouvé, il ne peut être abaissé à la main à sa place normale.

2. **Hydrocèle :**



Epanchement séreux de la vaginale tuméfaction rénitente non réductible, non impulsive à la toux permettant de la différencier d'une hernie inguinale

3. **Gros testicule :**

Tuméfaction intra scrotale avec un epididyme normal, chez un sujet jeune : Cancer de testicule

4. **Orchi-epididymite aigue :**

Tuméfaction du scrotum : rouge, œdémateux, chaud et douloureux, l'épididyme est épaissi et sensible, s'accompagnant souvent de fièvre et d'infection urinaire

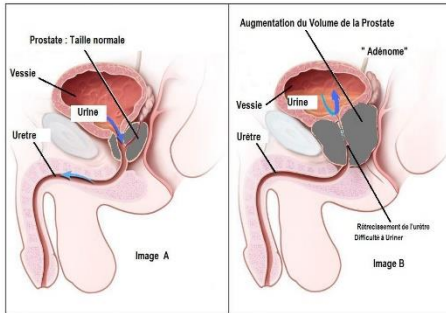
5. **Torsion du testicule :**

Torsion du cordon spermatique autour de l'hymen et son enroulement sur lui-même affectant vaisseaux & nerfs destinés au testicule & déférent.

6. Varicocèle :

Dilatation anormale des veines spermatiques (plexus pampiniformes)

7. L'adénome de la prostate :



Il se manifeste par des signes fonctionnels urinaires : pollakiurie, rétention aiguë d'urine ou rétention chronique incomplète et au TR la prostate est augmentée de volume, dans son ensemble, elle est bombante, volumineuse, arrondie en balle de tennis, ferme et élastique régulière, le sillon médian n'est plus perceptible.

8. Le cancer de la prostate :

Il peut être révélé par des signes fonctionnels urinaires : pollakiurie, dysurie et hématurie.

Le TR met en évidence soit une prostate contenant un ou plusieurs nodules d'une dureté pierreuse, soit une prostate augmentée de volume avec conservation du sillon médian mais uniformément indurée, de consistance pierreuse.